

Vaeste hoolekandest sotsiaalhoolekandeks



Jüri Kõre, Ph.D

Artikli¹ eesmärk on analüüsida hoolekande korraldust Eestis käesoleval hetkel, silmas pidades laiemalt riigi sotsiaalpoliitika arengusuundumusi ning kitsamalt 2016. a kehtima hakanud uue sotsiaalhoolekande seaduse konteksti. Artikli autori hinnangul sõnastab seadus kardinaalselt ümber Eesti hoolekande aluseks olevad põhimõtted, suunates sotsiaaltöö varasemalt vaesema elanikeosa probleemistikuga tegelemiselt läbivalt kogu ühiskonda hõlmavaks süsteemiks. 2017. a toimunud haldusterritoriaalne reform tingib muudatusi kohalikus hoolekandekorralduses. Mõistlik on neid muudatusi teha ühes kogumis seadusest tulenevate nõudmiste täitmisega. Kuigi Eestis tehtavate sotsiaaluuringute hulk on märkimisväärselt suur, on mõned valdkonnad alakaetud: heaoluriigi kui sotsiaalkaitse üldise raamistiku analüüs, sotsiaalsed õigused, sotsiaalhoolekande korraldus, sotsiaaltoetuste ja teenuste sisuline tõhusus ja majanduslik efektiivsus. Nende teemade käsitus uurijate poolt annaks olulise panuse sotsiaaltöö praktikasse.

Sissejuhatus

Eesti viimase veerandsajandi sotsiaalkaitse arengus võib eristada kolme etappi. Esimese etapi (üleminekuperioodi, 1980. aastate lõpust kuni 1990. aastate lõpuni) alguses toimus üsnagi piiratud informuuri tingimustes ideekorje Eesti sotsiaalkaitse tuleviku kohta. 1992. aastal algas uute seaduste vastuvõtmine, millega rajati praeguse sotsiaalkindlustuse ja -hoolekandesüsteemi alused. Teise etapi käivitasid 1998. aastal alanud liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga, mille käigus valmistati ette ELi õigustiku (*acquis*) ülevõtmine. Nüüdseks on 2004. aastal toimunud liitumisest möödas rohkem kui kümme aastat,

kuid kõik sotsiaalkaitse valdkonnas Brüsseliga kokkulepitu pole veel ellu viidud. See teadmine ei kummuta fakti, et Eesti elanikele algas 1998. aastal kiire sotsiaalsete õiguste laienemise etapp, mis sisuliselt lõppes 2008. aastal Eestisse jõudnud ülemaailmse majanduskriisiga. Seoses viimasega vähendati sotsiaalkaitse ulatust (hüvitiste saamise õigust ja hüvitiste määra) peaaegu kõigis sotsiaalkindlustuse ja mitmetes teenuste (näiteks tervishoiuteenused) valdkonnas. Majanduskriisiga alanud kolmanda sotsiaalkaitse kümnendi domineeriva ideoloogia on aimatav ameerikalik *workfare* paradigma² (vt Ewijk 2009). Kontseptuaalne muutus toimus ka hoolekandes, mida kajastab

¹ Artikkel on kirjutatud Tallinna Ülikooli 08.09.2017 konverentsil „Teadus- ja arendustöö sotsiaaltöö valdkonnas” peetud ettekande põhjal.

² Toetusskeem, milles osalevad tööealised inimesed peavad sotsiaalabi saamise tingimusena tegema avalikke töid, osalema koolitusel vms tegevustes, mis toetavad nende tööturule minekut. Sõna *workfare* asemel kasutatakse vahel ka mõistet *work+(wel)fare*.

2015. a vastu võetud uus sotsiaalhoolekande seadus (edaspidi SHS). Varasema seaduse vaestehoolekande alane suunitlus asendus universaalse (kõigile mõeldud) hoolekande põhimõttega. Tervikuna on praegune seis sotsiaalkaitstes siiski vastuoluline ja tulevasi arenguid on raske prognoosida.

Eesti heaolurežiim

Keskendumise tõttu faktidele, seostele, komplekssusele jms ei sobi teadlased eriti revolutsioonääri (kiirete muutuste algataja) rolli. Pigem on nad poliitikute käivitatud reformide disainijad ja lõpuni arendajad. Teadlaste kirk täpsustada, täiendada, arendada võimaldab aga mustvalgeid ideoloogiapõhiseid ühiskonnakäsitlusi (vastandumised nii probleemide põhjuste kui ka lahenduste suhtes) mitmekesistada ja on aidanud ratsionalistlikuks nimetatava suundumuse arengule sotsiaalpoliitikas. Kui püüda piiritleda sotsiaalhoolekande kohta laiemas sotsiaaluuringute kontekstis, siis ei ole pilt sugugi halb (vt sotsiaalministeeriumi, PRAXISE, RAKe ja ESA kodulehekülge). Uuringuaruannete loend, mis käsitleb inimeste toimetuleku eri aspekte, erinevate sihtgruppide probleemistikku, poliitikate tulemuslikkust (mõju heaolule), sotsiaalprobleeme jms on päris pikk. Teisalt jääb siiski mulje, et mõned valdkonnad on esindatud keskmiselt tagasihoidlikumalt: näiteks heaoluriigi kui sotsiaalkaitse üldise raamistiku käsitlus, sotsiaalsed õigused, sotsiaalhoolekande korraldus, sotsiaaltoetuste ja teenuste sisuline tõhusus ning majanduslik efektiivsus.

Alustades sisulist arutelu, peatun kõige üldisemal sotsiaalkaitse raamistikul – heaoluriigi käsitlusel. Küsimus postsotsialistlike riikide heaolurežiimist (sotsiaalkaitse iseloomust) ei ole suurt huvi pakkuv uurimisteema. Üldiselt kasutatakse selle riikide grupi puhul lihtsalt formuleeringut *postsotsialistlik heaoluriik* (Cerami 2008). Euroopa Kohtu kohtunik

R. Maruste väidab (1997), et sotsiaalriikluse ja demokraatliku õigusriikluse kategooria on Eesti põhiseaduse põhimõtteks. Seega on heaoluriigi ehk sotsiaalriigi ehitamine/arendamine ühiskonna/riigi/kodanikkonna üldine kohustus. Samas ta konstateerib, et sotsiaalsete õiguste käsitlemine põhiõigustena, mis annaks inimesele aluse õiguslikult nõuda riigilt teatud sotsiaalseid teenuseid, on küsitav. „See küsimus ei ole õiguslik-konstitutsiooniline, vaid sotsiaal-poliitiline”, märgib Maruste (1997, 72). Raske on hinnata, kas Maruste arusaama sotsiaalriiklusest mahub normatiivne lähenemine. Näiteks põhimõte, et miinimumsissetuleku garanteerimise (toimetulekutoetuse maksmise) süsteem peaks kindlustama vaesuspiirist kõrgema sissetuleku. Kui mitte, siis on Eesti sotsiaalriik tühi kest, sest ära nullitakse elementaarsed valdkondlikud põhimõtted (sotsiaaltoetus peaks olema piisav süvavaesuse vältimiseks, Andrews ja Ringold 1999). Kõige põhjalikumalt on Balti riikide, sh Eesti sotsiaalkaitset analüüsinud J. Aidukaite (2004 ja 2009), kuid temagi paneb Eesti heaolurežiimile mõneti ebamäärase postsotsialistliku heaoluriigi sildi. Täpsemat määratlust kasutavad A. Trumm ja M. Ainsaar (2008), defineerides Eestit marginaalse-universaalse ning Toots ja Bachmann (2010) neoliberaalse-postkommunistliku heaoluriigina. Trummi ja Ainsaarega sarnane on Reiljani, Laaseri ja Schraderi (2014) Eesti heaoluriigi kirjeldus, mille kohaselt pakub see vaid elementaarset sotsiaalkaitset, jäädes alla arenenud Euroopa riikides kehtivatele standardite. Toetudes Moreli, Palieri ja Palme (2012) heaoluriigi käsitlusele (keinsiaanlik paradigma 1950–1970 aastate I pool, neoliberaalne paradigma alates 1970. aastate lõpust, sotsiaalinvesteeringute paradigma alates 1990. aastatest), jõuavad Lauri ja Toots (2015) järeldusele, et ka Eesti sotsiaalkulutustes on märgatav nihe sotsiaalinvesteeringute

paradigmal põhineva sotsiaalkaitse korralduse suunas. Arvesse võttes sotsiaalkulutuste üldist madalat taset, ei ole käesoleva artikli autori hinnangul seda nihet siiski veel toimunud.

Võrdne õigus hoolekandele – vaestehoolekandest kõigi hoolekandeks

Kindlasti ei ole kõik käesoleva teksti lugejad nõus allakirjutanu seisukohaga: 2015. a vastu võetud uue sotsiaalhoolekande seadusega muutus Eesti hoolekandes varasem vaestele suunatud rõhuasetus üldiseks, kõigile suunatud abi süsteemiks, st selektiivsest universaalseks. Kuna pikemat perioodi puudutav selektiivsuse-universaalsuse analüüs nõuab aega ja selle esitlus trükimahtu, otsime eelnevale väitele kinnitust ainult Maailmapanga analüüsist pikaajalise hoolduse olukorra kohta Eestis. Selles esitatud pikaajalise hoolduse stsenaariumid mahuvad nn *status quo* ehk praeguse teenusekorralduse jätkumise (teenuste sihtgrupp on vaesed) ja ideaalse süsteemi (universaalne vajaduspõhine teenusekorraldus) vahele (World Bank 2017). Kehtivas SHSs toimunud muudatustest on kõige olulisemad kaks. Esiteks on kadunud vastandumine kahe mõiste, abivajaja ja kodanik, pinnal. Teiseks ei käsitleta hoolekannet kui eraldi seisvat valdkonda, vaid see on osa üldisest ühiskondliku elu korraldusest. Piisab, kui viimase seisukoha selgitamiseks nimetame mõistet deinstitutionaliseerimine.

Niisiis, universaalsus on:

- 1) kõigi Eestis seaduslikult viibivate isikute üldine õigus abile sõltumata sotsiaalmajanduslikust taustast (elu- või asukoht, perekond, sissetulek vms)
- 2) sihtgrupi asemel vajaduspõhine probleemi ja abi käsitlus
- 3) standardid või miinimumnõuded teenustele-toetustele, mis aitavad ühtlustada abi geograafilises plaanis

- 4) teenusekorralduses lähtumine universaalse disaini põhimõttest (teenusepakkumine mitmeprofilsetes institutsioonides või kasutades erinevatele gruppidele sobivaid meetodeid)
- 5) tõrjutuse kui riskiteguri konstateerimise asemel kaasamise kui motiveeriva ja toimetulekut toetava ressursi kasutamine
- 6) rõhuasetuse muutus institutsiooni- (ka sotsiaaltöötaja-ametnik on institutsioon) põhiselt teenusekorralduselt võrgustiku- ja kogukonnapõhisele teenusekorraldusele. See nõuab praeguse, valdavalt mitteformaalse sektoritevahelise koostöö asendamist formaliseeritud suhetega
- 7) toimetuleku kindlustamine kliendi kaasamise ja talle valikuvõimaluse pakkumise kaudu.

Õiguskantsler käsitleb sisuliselt sama universaalsuse teemat omavalitsuse näitel järgnevalt: 1) KOV peab tagama SHSga sätestatud teenuste olemasolu; 2) selgitama välja toimetulekuprobleemi lahendamiseks vajaliku abi; 3) jälgima, et abi oleks isikule rahalises mõttes kättesaadav (Ploom 2017). Need kolm kriteeriumit on lihtsaim mõõdupuu, kuidas hinnata liikumist universaalse hoolekandekorralduse poole.

Teenuste miinimum

Kirjeldamaks kodanike sotsiaalsete õiguste realiseerimise seisu, esitan andmed sotsiaalteenuste kohta omavalitsustes (tabel 1).

Haldusreformi järel pilt muutub, sest tabeli viimane tulp kirjeldab hüpoteetilist teenustega kaetust uutes ühendamavalitsustes. Kuigi selle prognoosi järgi ligineb teenuste olemasolu 100 protsendile, on teenuste mahu kasvu keeruline hinnata. Liitumislepingute analüüs annab hoolekande tuleviku kohta vastuolulisi signaale. Lepingutes kasutatavast formuleeringust „pakutavate teenuste taseme säilitamine” võib välja lugeda soovi saavutada n-ö prima

Tabel 1. Hoolekandeteenuste kättesaadavus 2011 ja prognoos haldusreformi järgse olukorra kohta

	2011, 154 omavalitsust ¹			2017, 79 omavalitsust ²
	Osutavad teenust	Küsiivad tasu	Arvestavad tasu küsimisel varalist seis	
Nõustamine	151	5	3	
Võlanõustamine				44/ESF 63
Eluasemeteenus	143	131	80	77
Koduteenus	141	82	52	76
Üldhooldekoduteenus	140	136	96	64
Täisealise isiku hooldus				74
Eluruumi kohandamine	97	75	47	
Isikliku abistaja teenus	76	43	23	35
Tugiisiku teenus				74/ESF 46
Hooldamine päevakeskuses	62	34	17	
Sotsiaaltranspordi teenus				67
Naiste varjupaiga teenus	61	25	15	
Kodutute varjupaiga teenus	55	29	16	16

¹ PRAXIS/Emor 2011² Veermäe 2017

liitja teenusekorraldus. Teisalt on mitmetes lepingutes must-valgel kirjas, et sotsiaalteenuste osutamist jätkatakse senistel tingimustel. Kas see tähendab, et varasemad omavalitsuste vahelised erinevused teenuste kättesaadavuses ja hulgas kanduksid uutesse omavalitsustesse (Kriisk 2017)? Kumb tõlgendus on õige, sellele saame vastuse paari aasta pärast. Soome 2011. a ebaõnnestunud omavalitsusreformi puhul oli ümberkorralduste kavandamisel peamiseks eesmärgiks/kriteeriumiks omavalitsuste võimekus osutada omateenitud tulude arvel sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid (André ja García 2014). Eesti haldusterritoriaalse reformi paljusõnalisest eesmärgi kirjeldusest on hoolekannet kui prioriteeti raske leida („Eesmärgiks on /.../ kasvanud KOVi kompetents ja võimekus kindlustada

elanikele kvaliteetsed avalikud teenused”, vt *Haldusreformi kontseptsioon* 2015).

Abivajaduse ja teenuste sobivuse hindamine

Käesolev periood omavalitsuskorralduse arengus on parim aeg sotsiaalhoolekande teenustele miinimumnõuete (standardite) seadmiseks. Omavalitsuste enamikku puudutavad ühinemised või liitumised nõuavad valdkonnas niikuinii nii formaalseid kui ka sisulisi ümberkorraldusi. Miinimumnõuete kasutuselevõtu taust on umbmäärane. Ühelt poolt paneb SHS omavalitsusele kohustuse kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra. Teisalt antakse seadusega Vabariigi Valitsusele / vastutavale ministrile õigus kehtestada määrusega täpsustatud

nõuded KOV teenuste eesmärgile, sisule ning tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks. Teenusekorralduse üldpõhimõtteks (SHS § 3 p 4) on, et abi andmisel lähtutaks abimeetme rakendamise tulemuslikkusest. Seega ei saa abi korraldus olla suvaline ja toetuda näiliselt kogukonna eripärale, vaid peab olema tõenduspõhine ja seetõttu paratamatult mahtuma kindla raamistiku (standardi) sisse.

Millisesse raamistikku peaks teenus mahutama, seda on huvitav analüüsida päevakeskuse näitel. Päevakeskuse teenust iseloomustab esiteks see, et tegemist on suurima kliendi-arvuga sotsiaalteenusega (2015. a kokku 48 tuhat klienti, sh 15 tuhat püsiklienti) ja teiseks asjaolu, et otseselt moodustavad sotsiaal- ja tervishoiu (tervisedenduse) teenused kõigist päevakeskustes osutatavatest teenustest vaid $\frac{1}{5}$ (22%). Domineerivad teenused on hoopis toitlustamine, huvitegevus ja üritused. Neid kolme kasutab või neis osaleb $\frac{2}{3}$ (57%) klientidest (vt *Päevakeskuse teenused 2011–2015*, Sotsiaalministeerium). Mingil juhul ei saa väita, et päevakeskus asutusena ei ole eelkõige eakatele kogukonnaliikmetele vajalik. Kuid ülekaalus olevad tegevused viitavad sellele, et pigem on tegu kogukonnakeskusega. Üldjuhul on hoolekandeteenuseid osutav päevakeskus osa pikaajalise hoolduse (ingl *long-term care*, LTC³) kompleksist. Meil võib 48 tuhandest päevakeskuse kliendist reservatsioonideta pikaajalise hoolduse saajate hulka arvata ainult päevahoiu teenusel olevad 534 isikut (samas, Sotsiaalministeerium).

Tasu teenuse eest ja kliendi maksevõime

Üks viimastel aastatel riigi ja omavalitsuste ning omavalitsuste ja kodanike vahel pingeid tekitav teema on teenuste eest tasumine (laiemalt teenuste korralduse eest vastutamine). Kohtusse jõudnud vaidlused rahastuse üle on saanud erinevaid lahendusi. Seetõttu pole tänaseni kindlust, kuidas ühes või teises situatsioonis toimida. Õiguskantsleri näpunäidete kohaselt peab omavalitsus (ehk sotsiaaltöötaja) hindama, mil määral on isik ja tema pere võimeline hoolekandeteenuse eest maksma, ilma et teised elulised vajadused kannataksid (Ploom 2017). Seda on praktikas üsna keeruline täita. Enamikul juhtudel põhinevad sotsiaaltöös hüvitiste määramise otsused sissetuleku kokkulepitud piiridel vms kriteeriumidel. Ressursipuudusest (võimetusest maksta teenuste eest) tuleneva kahju hindamine on pigem haruldane kui mitte olematu. Et selline normatiivne lähenemine pole Eestile ainuomane, toon näitena abikaasa (registreeritud partneri) hoolekandelasel vastutuse piiritlemisest Soomes: kuigi ta peab osalema abikaasa/partneri institutsionaalse hoolduse kulude eest tasumisel, on sissetuleku osa, mis jääb tema kasutada, väga täpselt reguleeritud⁴ (City of Helsinki 2017).

Viimase kümne aasta jooksul ei ole kahe sisuliselt sama eesmärgi täitva teenuse, kodu- ja institutsionaalse hoolduse, rahastamise proportsioonid Eestis muutunud. Üldhooldekodu teenuse peamine rahastaja oli ja on teenusekasutaja ja tema pere (2007. a

³ Pikaajaline hooldus (ingl *long-term care*, LTC) – omavahel seotud (üheaegselt või järjestikku osutatavate) hoolekande- ja tervishoiuteenuse kompleks pikaajalist abi vajavatele isikutele. Riigiti on vastavate üksikteenuste loetelu erinev, kõige sagedamini esinev kombinatsioon on koduhooldus (toetus omastehooldajale ja koduhooldusteenus), kodune õendusabi, päevakeskuse teenus, hooldekodu teenus. Kuigi sisuliselt on tegemist lühiajalise abiga, loetakse pikaajalise hoolduse osaks ka omastehooldajate vajadusi arvestades korraldatud asendushooldust, intervallhooldust jms (näiteks neli nädalat aasta jooksul). Eestis pole kombineeritud pikaajaline hooldus ametlikult defineeritud mõistena kasutusel.

⁴ Kodus olevale abikaasale peab kätte jääma vähemalt eluasemekulude katmiseks vajalik ja igapäevaste elamiskulude katmiseks rahvapensioni suurune rahasumma.

Tabel 2. Üldhooldekodu ja koduhooldusteenuse rahastamine

	Üldhooldekodu teenus		Koduhooldusteenus	
	2007	2016	2007	2016
Kokku	23 015 887	28 880 244	4 035 678	6 117 410
Riik	242 253	223 757	25 144	6 986
Kohalik omavalitsus	9 353 013	11 037 447	3 939 029	5 809 138
Teenuse kasutaja ja tema pere	13 413 201	17 540 113	69 155	293 481
Muu	7 420	78 927	2 351	7 805

ALLIKAS: SOTSIAALMINISTEERIUM

58 ja 2016. a 61% kogu kulust, vt tabel 2), koduhooldusteenuse maksab kinni kohalik omavalitsus (98 ja 95%).

Mõlema teenuse puhul võtavad omavalitsused näiliselt peaaegu ühesugusel määral arvesse isiku varalist seisu (tabeli 1 andmetel hooldekodu puhul 70% ja koduhooldusteenuse puhul 63% omavalitsustest). Sisuliselt on nende kahe teenuse korralduse mudelid siiski üsna erinevad: koduhoolduse puhul on teenusele saamise tingimused selgelt

soodsamad üksikute eakate kogukonna-liikmete jaoks.

Teenuste korralduse mudelid, millistes eri sihtgruppide jaoks kehtivad erinevad reeglid, ei ole lõpptulemusena efektiivsed. Kujuka tõestuse sellele saame inglase prognoosist teenuse kasutuse proportsioonide võimaliku arengu kohta: KOV rahastatud teenuste puhul prognoositakse järgneva kahekümne aasta jooksul koduhooldusteenuste 1,8 ja institutsionaalse teenuse 1,5 kordset kasvu.

Tabel 3. Kodu- ja institutsionaalne hooldus – näide rahastamismudeli mõjust teenuste mahule (Inglismaa, klientide arv tuhandetes)

	2015	2035	Juurdekasv
65+ rahvastik	2 890	4 770	65%
Toimetulekuhäire (toimetulematus vähemalt ühe ADL või IADL indeksi ⁵ tunnuse osas)	1 150	1 990	73%
KOV rahastatud koduhooldus	257	468	82%
KOV rahastatud institutsionaalne hooldus	172	257	49%
Isiku rahastatud koduhooldus	94	140	49%
Isiku rahastatud institutsionaalne hooldus	157	330	110%

ALLIKAS: WITTENBERG JA HU 2015

⁵ ADL indeks – igapäevaeluga (söömine, riietumine, tualeti kasutamine) toimetulekut kirjeldav indeks, tuntud ka kui Katzi indeks (*The Katz Index of Independence in Activities of Daily Living*, vt Katz jt 1963). IADL indeks – keerukamate igapäevatoimingutega (söögi tegemine, poes käimine, rahaga ümberkäimine jms), mõnikord ka kogukonnas hakkamasaamist kirjeldav indeks, tuntud ka kui Lawtoni skaala (*Lawton's Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale*, vt Lawton ja Brody 1969).

Isiku (perekonna) rahastatud teenuse puhul on suhe vastupidine: koduhooldusteenuse maht kasvab 1,5 ja institutsionaalne teenuse oma 2,1 kord. Ühiskonnale tervikuna on rahaliselt soodsam KOV poolt järgitav teenuste proportsioon. Teenuste rahastusmehhanismid sunnivad neid, kes ise tasuvad oma teenuste eest, tegema teistsuguse valiku (teenust rahastatakse eluaseme müügi summadest vms).

Kokkuvõtteks

Eesti kui heaoluriigi põgus analüüs ei anna vastust küsimusele, millist ühiskonda peetakse heaks ja millist heaolurežiimi kui selle ühiskonna toimimise mehhanismi püütakse üles ehitada. Sotsiaalpoliitilise mõtte ebaselgus ei ole toetanud hoolekande arengut. Omavalitsustasandil on sotsiaaltöötajad üldise raamistiku puudumise tõttu tegutsenud hetkevajaduste/võimaluste piirides ning tõhusaima hoolekande mudeli loomine on jäänud pigem tuleviku hooleks. Kuigi praktika mitmekesisus (omavalitsuste erinev hoolekandekorraldus) pakub häid võimalusi analüüsiks, ei ole seni

tehtud analüüside hulk olnud piisav, tekitamaks teoreetikute vahel dialoogi.

Samuti võib analüüsi põhjal väita, et 2016. aastal kehtima hakanud sotsiaalhoolekande seaduse uus redaktsioon muutis olulisel määral omavalitsushoolekande eesmärki ja iseloomu. Varasem rõhuasetus vaestehoolekandele asendus universaalse, kõigile mõeldud hoolekande põhimõttega. See muudatus tähendab vajadust uuendada nii sotsiaalteenuste planeerimise, korralduse kui ka rahastamise põhimõtteid. 2018. a hakkas enamik Eesti omavalitsusi tegutsema uutes, haldusreformi järgsetes piirides. Paratamatult on uue geograafilise ja sotsiaaldemograafilise reaalsuse kõrval vaja sotsiaaltöö ümberkorraldamisel arvesse võtta ka viidatud seadusest tulenevaid nõudeid. Nimelt: kõigil samade vajadustega kogukonnaliikmetel on ühesugused õigused; abi, mida omavalitsus pakub (korraldab), peab olema tulemuslik; kasutatavad teenuste rahastusmudelid peavad jätma hoolekande klientidele võimaluse tegutseda edasi aktiivsete kogukonnaliikmetena. **S**

Viidatud allikad

- Aidukaite, J.** (2004). The Emergence of the Post-Socialist Welfare State. The Case of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. Södertörns högskola.
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16651/FULLTEXT01.pdf. (26.02.2018).
- Aidukaite, J.** (2009). Old welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges and implications. *Communist and Post-Communist Studies*, 42(1), 23–39.
- André, C., García, C.** (2014). Local Public Finances and Municipal Reform in Finland. OECD Economics Department Working Papers.
www.oecd-ilibrary.org/economics/local-public-finances-and-municipal-reform-in-finland_5jz2qt0zj024-en. (26.02.2018).
- Andrews, E., Ringold, D.** (1999). Safety Net Reform Strategy in Transition Economies. Mimeo, World Bank, Washington D.C.
- Cerami, A.** (2008). Europeanization and Social Policy in Central and Eastern Europe. Teoses: François Bafoil and Timm Beichelt (toim.) *Européanisation. D'Ouest en Est. Coll. Logiques Politiques*, L'Harmattan: Paris.
- City of Helsinki.** Institutional care for the elderly
www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/service-description?id=4582. (26.02.2018).
- Ewijk, H. Van.** (2009). European Social Policy and Social Work. Citizenship based social work. Abingdon Routledge.

- Haldusreformi kontseptsioon.** Eelnõu 17.12.2015. Rahandusministeerium.
www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/kov/151218_haldusreformi_kontseptsioon.pdf (26.02.2018).
- Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., Jaffe, M. W.** (1963). Studies of illness in the aged: The index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA*, 185(12), 914–919.
- Lauri, T., Toots, A.** (2015). Eesti heaolupoliitika uuemate heaoluküsitluste taustal. Teoses: Vetik, R. (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015. Löksudest välja (20–25). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu.
www.kogu.ee/wp-content/uploads/2015/06/EIA-2015.pdf (06.03.2018).
- Lawton, M. P., Brody, E. M.** (1969). Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *Gerontologist*, 9, 179–186.
- Maruste, R.** (1997). Põhiseadus ja selle järelvalve. Võrdlevad selgitused. Kommentaarid. Tekstid. Juura.
- Paine, M.** (2014). *Modern Social Work Theory*, Fourth Edition, Palgrave Macmillan.
- Pihor, K., Timpmann, K., Batueva, V.** (2011). Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine. Uuringu aruanne. SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, AS EMOR
www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/08/Kohaliku-omavalitsuse-poolt-isikult-jav%C3%B5i-perekonnalt-sotsiaalteenuste-est-tasu-n%C3%B5udmine.pdf (26.02.2018).
- Ploom, K.** (2017). Kohaliku omavalitsuse väljakutsed sotsiaalteenuste osutamisel. *Sotsiaaltöö, 1 Päevakeskuse teenused 2011–2015*, Sotsiaalministeerium.
- Reiljan, J., Laaser, C.-F., Schrader, K.** (2014). Structural weaknesses as barriers to social progress in Estonia. University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration Working Paper Series, 96, 1–23.
- Toots, A., Bachmann, J.** (2010). Contemporary Welfare Regimes in Baltic States: Adapting Post-Communist Conditions to Post-Modern Challenges. *Studies of Transition States and Societies*, 31–44.
www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2010/11/TootsBachmann.pdf (26.02.2018).
- Trumm, A., Ainsaar, M.** (2008). Zwischen Marginalität und Universalismus: Das estnische Wohlfahrtssystem. Teoses: Schubert, K., Hegelich, S., Bazant, U. (toim) Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch Wiesbaden: Springer Verlag. 187–207.
- Veermäe, E.** (2017). Sotsiaalvaldkonna väljakutsed. Ettekanne ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil 30.10.17.
- Wittenberg, R., Hu, B.** (2015). Projections of Demand for and Costs of Care for Older People and Younger Adults in England, 2015 to 2035. PSSRU Discussion Paper 2900.
www.pssru.ac.uk/pdf/DP2900.pdf. (06.03.2018).
- World Bank** (2017). Reducing the Burden of Care in Estonia. Interim Report.
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/hoolduskoormus/estonia_ltc_report_final.pdf. (06.03.2018).